Estratégia MED



CIRURGIA

PROF. SARAH COZAR

NEOPLASIAS DO APÊNDICE CECAL

RESUMO **ESTRATÉGICO**

2024

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



APRESENTAÇÃO

PROF. SARAH COZAR

Olá, aluno do Estratégia MED!

Venho alertá-lo de que este não é um tema cobrado com muita frequência. Quando abordado, em geral, a banca costuma trazer um paciente submetido à apendicectomia simples por apendicite aguda que, em consulta de retorno pós-operatório, traz a análise histopatológica do espécime cirúrgico, que identifica um tumor apendicular. Dada essa situação problema, eu pergunto a você: qual é a conduta para esse paciente? Ele está curado após a apendicectomia? Deve voltar à mesa de cirurgia ou realizar algum tratamento complementar, como quimio ou radioterapia?

É sobre a conduta nos diferentes tumores do apêndice que discutiremos aqui! Não deixe de reservar um tempo para aprofundar seu estudo no tema. Acesse nosso livro digital de Neoplasias do Apêndice Cecal. Nele, dedicamos um capítulo inteirinho aos tumores do apêndice cecal!

Desejo a você uma excelente leitura!

Estratégia MED

@estrategiamed

@estrategiamed

t.me/estrategiamed

/estrategiamed

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

SUMÁRIO

1.0. INTRODUÇÃO 4
2.0 TUMORES NEUROENDÓCRINOS DO APÊNDICE 4
3.0 ADENOCARCINOMA DO APÊNDICE 5
4.0 MUCOCELES DO APÊNDICE 5
4.1 PSEUDOMIXOMA PERITONEAL 5
5.0 LISTA DE QUESTÕES 7
6.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 8
7.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 9

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
1.0. INTRODUÇÃO

As neoplasias primárias do apêndice são infrequentes. Ainda que sua incidência, por razões desconhecidas, esteja aumentando, elas representam apenas aproximadamente 0,5% a 01% das neoplasias intestinais e são encontradas em cerca de 01% das amostras de apendicectomia.

Os neoplasmas apendiculares compreendem vários tipos histológicos (tabela 01), amplamente categorizados como **tumores neuroendócrinos** (também conhecidos como carcinoides do apêndice) e **neoplasias epiteliais.** Esses tumores apresentam diferenças prognósticas, o que reflete em seu tratamento.

	Tabela 01: Histopatologia dos tumores apendiculares
1	Tumor neuroendócrino (carcinoide do apêndice).
2	Neoplasias epiteliais.
A	Adenocarcinoma mucinoso.
B	Adenocarcinoma intestinal ou colônico.
C	Adenocarcinoma tipo células em anel de Sinete.

O **adenocarcinoma mucinoso** é o tipo histológico mais frequente (38% do total de casos reportados), seguido do adenocarcinoma intestinal ou colônico (26%). O tumor carcinoide compreende apenas 17% dos casos.

CAPÍTULO
2.0 TUMORES NEUROENDÓCRINOS DO APÊNDICE

O carcinoide do apêndice é normalmente descoberto de forma incidental, após análise histopatológica do produto de apendicectomia por apendicite aguda. Dessa forma, é necessário decidir se o paciente deve ou não retornar à sala de cirurgia.



Guarde estas informações: a simples apendicectomia será suficiente àqueles pacientes com tumores neuroendócrinos bem diferenciados com tamanho inferior a 01 cm.

Hemicolectomia direita com linfadenectomia deverá ser realizada nos pacientes com tumor ≥ 02 cm ou naqueles com tumor entre 01 cm e 1,9 cm, desde que apresente qualquer uma das características listadas abaixo:

- Localização na base do apêndice;
- Invasão profunda (> 03 mm) do mesoapêndice;
- Margens cirúrgicas positivas ou pouco claras;
- Maior índice proliferativo (grau ≥ 2); e
- Invasão angiolinfática.
- Histologia mista (por exemplo, adenocarcinoma de células caliciformes)

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Diferentemente da apendicectomia simples, a colectomia remove os linfonodos que recebem a drenagem linfática do apêndice e qualquer doença residual que possa permanecer na base do apêndice ou no mesoapêndice.

CAPÍTULO

3.0 ADENOCARCINOMA DO APÊNDICE

O tratamento recomendado para praticamente todos os adenocarcinomas apendiculares não metastáticos, sem ruptura e completamente ressecados, encontrados incidentalmente em uma amostra de apendicectomia, é a **hemicolectomia direita, com linfadenectomia**.

Para pacientes com doença linfonodal, sugere-se, ainda, um curso de seis meses de quimioterapia adjuvante, com esquemas contendo fluoracil e oxaliplatina, de forma semelhante ao empregado no adenocarcinoma colorretal.

CAPÍTULO

4.0 MUCOCELES DO APÊNDICE

A mucocele do apêndice é a distensão do órgão devido ao acúmulo intraluminal de material mucoide, resultado de obstrução do orifício apendicular. É uma patologia rara, representa apenas 0,2 a 0,3% das apendicectomias, com predomínio em mulheres por volta da sexta e sétima década de vida. As mucoceles podem ser causadas por cistos de retenção, hiperplasia mucosa, cistoadenoma e cistoadenocarcinoma. Uma mucocele intacta não representa riscos futuros para os pacientes e não determina a necessidade de executar uma hemicolectomia direita. Quando identificada no intraoperatório, deve-se proceder à ressecção do apêndice com o seu mesoapêndice, realizando-se todo o esforço para manter a mucocele intacta. A hemicolectomia direita destina-se a pacientes cuja margem foi positiva na base do apêndice ou quando são identificados linfonodos periapendiculares positivos.





4.1 PSEUDOMIXOMA PERITONEAL

A mucocele pode se romper e, consequentemente, haverá um envolvimento peritoneal mucinoso difuso, com implantes mucinosos nas superfícies peritoneais e no omento, originando o PSEUDOMIXOMA PERITONEAL. Mais frequentemente, ocorre na ruptura de um cistoadenoma do apêndice - agora denominado neoplasia mucinosa de baixo grau do apêndice.

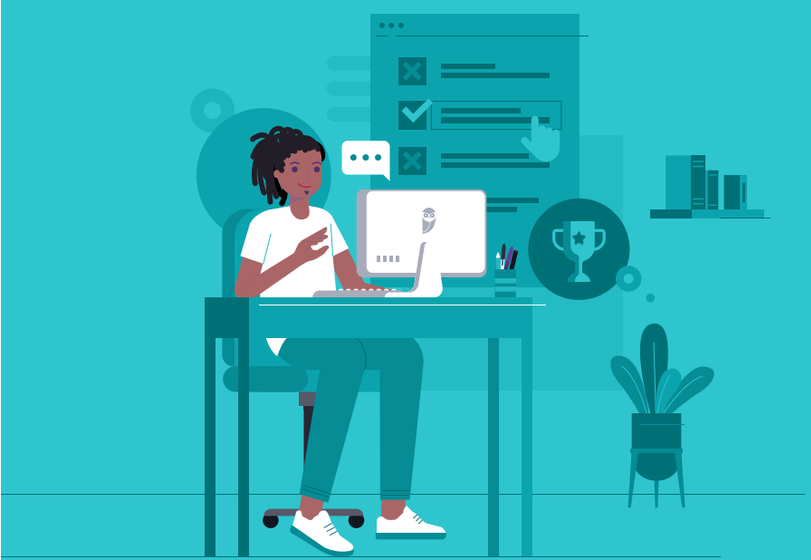
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

O tratamento principal envolve a cirurgia citorredutora. Toda a doença bruta e o omento devem ser removidos. Nas mulheres, realiza-se a histerectomia com salpingo-ooforectomia bilateral. A quimioterapia intraperitoneal adjuvante é mantida como padrão adjuvante da cirurgia citorredutora radical (cirurgia citorredutora com quimioterapia hipertérmica intraperitoneal).

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/3aXGPCV

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

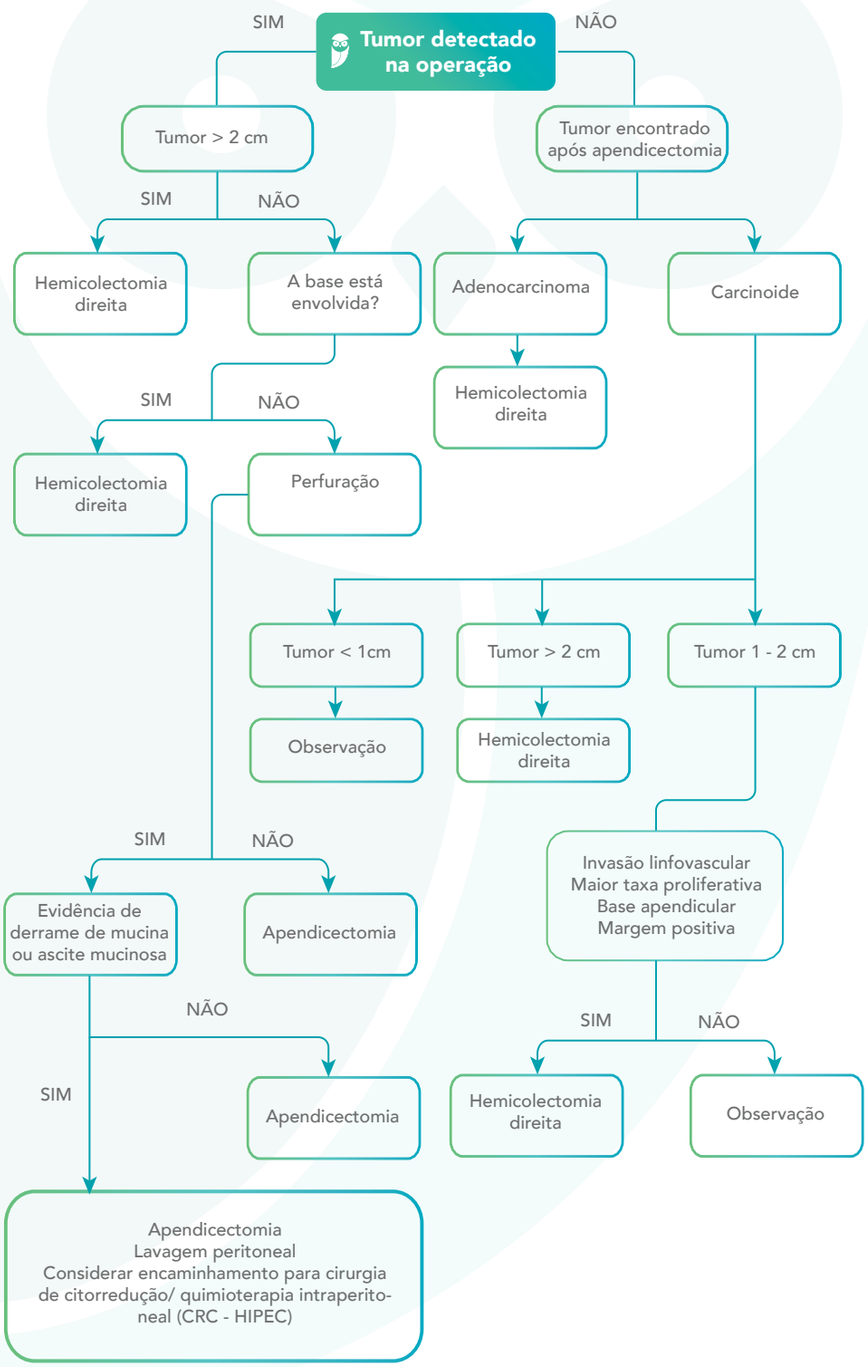
6.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Caro Estrategista!

Chegamos ao fim deste resumo! Viu como foi rápido? Ainda que o assunto não seja incidente com muita frequência, merece sua atenção, pois as questões sempre abordam os mesmos pontos, repetindo-se ano após ano.

Antes de me despedir, deixo aqui uma última tentativa de ajudá-lo a memorizar o que você precisa saber sobre o tema! Guarde este fluxograma com carinho para revê-lo antes das provas!





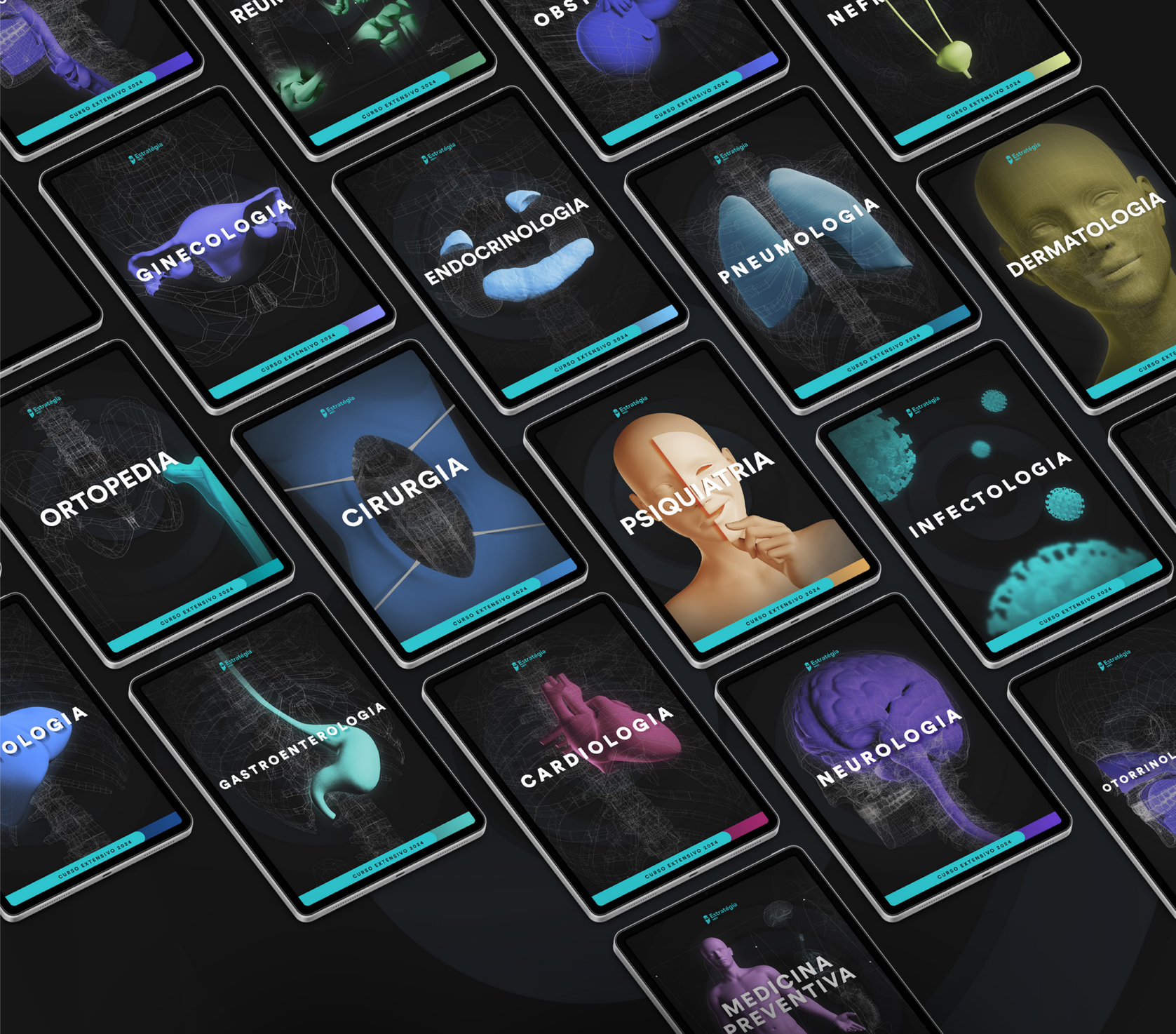
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

7.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Townsend, C. M., R. D. Beauchamp, B. M. Evers and K. L. Mattox. 2017. Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice, 20th edition. Elsevier Saunders.
2. Brunicardi, F. C., D. K. Andersen, T. R. Billiar, D. L. Dunn, J. G. Hunter, J. B. Matthews and R. E. Pollock. 2014. Schwartz's Principles of Surgery, 10th edition, McGraw-Hill Education.
3. Cameron, J. L., Cameron, A. M. 2013. Terapêutica Cirúrgica. 10a edição, Elsevier.
4. https://www.uptodate.com/contents/search

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina